

SH.GSR.05.ICD.10			رقم السياسة
تقييم أخطار السقوط وتفاديها			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
١٠	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الاقسام بالمستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة	إعداد	
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيسة التمريض م/ هيام محمود فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوى

- يلتزم العاملون بمستشفى صيدناوى باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المرضى للسقوط بجميع أقسام المستشفى، ويبدأ تقييم أخطار السقوط للمريض عند دخول المستشفى
- تلتزم المستشفى بتوفير التدابير العامة المستخدمة لتقليل خطر السقوط مثل أنظمة الاتصال والإضاءة، كراسي متحركة، تروليّات ذات حواجز جانبية وقفل عجل، و أي لوازم أخرى لتفادي سقوط المرضى
- يلتزم العاملون بوضع خطة مصممة خصيصا للمريض المعرض للسقوط ومسجلة ب ملف المريض، كما يلتزم جميع العاملين ب تنفيذ بنود الخطة
- يلتزم المستشفى بتوفير قائمة تعريفية بالأشخاص المعرضين لخطر السقوط، سواء كانوا من المرضى أو الزائرين، وذلك لمساعدة الكوادر العاملة في إجراء المسح البصري السريع.
- يلتزم العاملون بتوفير الأمان البيئي للمرضى المعرضة للسقوط:
 - منع الزحام بالغرفة
 - تنقيف المريض والاهل حول الجرس والإنذارات
 - ترك باب الحجرة مفتوح
 - توفير اضاءة ليلا بالغرفة
 - رفع جوانب السرير

الغرض

الوقاية من حوادث سقوط المرضى من خلال التقييم المستمر لمدى عرضتهم للخطر، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامتهم.

التعريفات

- السقوط: هو أي تغير مفاجئ وغير مقصود في وضعية المريض من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى، مما يؤدي إلى استقراره على الأرض أو على أي سطح آخر تحته.
- حالة على وشك السقوط: هو فقدان مفاجئ لاتزان الجسم لا ينتج عنه سقوط فعلي. يمكن وصفه بحدوث انزلاق أو تعثر، حيث يتمكن المريض (أو من يعاونه) من تدارك الموقف واستعادة توازنه دون أن يسقط.
- السقوط غير المُشاهد: هو السقوط الذي يُكتشف عندما يتم العثور على المريض ملقى على الأرض فجأة، دون وجود أي شاهد عيان، بحيث لا يُعرف على وجه التحديد متى وكيف حدث هذا السقوط.

إجراءات العمل

١. عند دخول المريض حرم المستشفى، يقوم موظفو الأمن بعمل فحص بصري سريع (screening) لجميع المرضى من خلال ملاحظة

○ طريقة مشى غير مستقرة.

○ استخدام أجهزة مساعدة للمشي والحركة (كرسي متحرك، سنادات للحركة، مشاية، متسند على شخص).

○ العجز البصري/السمعي.

○ حركة غير مستقر (يميل على شخص يمسك بالأثاث أثناء المشي).

● في حالة ملاحظة أي من العلامات السابقة يتم تقديم المساعدة لشخص وتوفير كرسي متحرك له.

٢. داخل الاستقبال:

تقوم الممرضة بتصنيف المرضى عن طريق فور دخولهم غرفة التصنيف لتمييز المرضى المعرضين لخطر

السقوط: في حالة وجود مريض يمكن تعرضه لخطر السقوط تقوم الممرضة بعمل الآتي:

○ توضع الممرضة أسورة باليد اليسرى للمريض عليها حرف F

○ رفع جوانب السرير.

○ ابلاغ الزملاء الممرضين والاطباء بان المريض عرضة للسقوط، كما يتم ابلاغ اهل المريض

٣. لمرضى الطوارئ

○ رفع حواجز السرير.

○ إمدادهم بالأجهزة المساعدة على المشي مثل الكرسي المتحرك.

○ مع إتباع كافة الاحتياطات الخاصة بمنع السقوط.

○ تقديم المساعدة واصطحاب المريض بعد الانتهاء من الزيارة حتى المدخل الرئيسي للمستشفى إن لزم الأمر.

٤. يتم اعلام مستلم المريض عن درجة احتمالية السقوط سواء كان تسليم بين ممرض واخر بين اقسام مختلفة او في

نفس القسم بعد انتهاء الشيفت والتسليم الى الشيفت الذي يليه

٥. يعتمد الممرض المقيم لمخاطر سقوط المريض على أداة تقييم أخطار السقوط المتاحة بالنماذج الخاصة للمستشفى:

• درجة التقييم ٣ أو أقل ← مريض غير معرضين للسقوط.

• درجة التقييم ٤ فأكثر ← مريض معرضين للسقوط.

٦. يتم استخدام اسورة تمييز للمرضى المعرضة للسقوط، مكتوب عليها حرف F

٧. مريضى الرعايةات جميعهم مريضى معرضين للسقوط، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة ب منع السقوط لجميع

المريضى داخل الرعايةات. لا يستلزم وضع اسورة التمييز F لمريضى الرعايةات داخل الرعايةات ، ولكن يتم تركيب

الاسورة في حال خروج المريض من الوحدة لتلقي أي خدمة خارج الرعاية. تقوم مشرفات الرعايةات ب تبليغ أي

عضو من أعضاء هيئة التمريض العاملين ب شكل مؤقت داخل الرعاية بالتعامل مع جميع المريضى داخل الرعاية

على انهم مريضى عرضة للسقوط ويتم اتخاذ كافة إجراءات تفادي السقوط معهم

٨. يتم تقييم المريضى لأخطار السقوط فور دخولهم المستشفى، و تتم إعادة التقييم في الحالات الاتية

• مرتين يوميا مرة صباحا و مرة مساء

• تغير حالة المريض الاكلينيكية او النفسية

• اخذ ادوية تؤثر على اتزان المريض

• مريضى العمليات: أي مريض يخضع لعملية جراحية او تدخل جراحي هو عرضة للسقوط ويتم اتخاذ

إجراءات منع السقوط لمدة ٦ ساعات بعد انتهاء العملية، عند إعادة تقييمه في حال وجد ان المريض

عرضة للسقوط يتم استكمال اتخاذ الإجراءات وتركيب اسورة التمييز F

• نقل من قسم لآخر ومن رعاية للأقسام الداخلي

• بعد حدوث سقوط للمريض

٩. بعض المريضى يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتفادي سقوط المريض دون تقييمهم:

• مريض لديه تاريخ سقوط

- مريض بتاريخ سكتة دماغية
 - مريض فقر الدم والانييميا
 - هشاشة العظام
 - مريض الضعف العام
 - الأشخاص الأكبر من ٧٠ سنة
 - تاريخ نوبات اغماء او دوخة
 - مريض على ادوية عالية الخطورة (مدرات البول – مخدرات – مهدئات – ادوية نفسية)
 - مريض الاعاقات العقلية (مثل متلازمة داون – التوحد – أخرى)
 - مريض الاعاقات الجسدية (فقد البصر – بتر سفلي – أخرى)
 - أطفال حديثي الولادة حتى ٦ أعوام
 - مريض الكلى والمريض الخاضعين لجلسات الغسيل الكلوي
 - مريض الأورام طبقا للأدوية التي يتم اخذها
 - أي مريض خاضع للصيام قبل اجراء يتطلب الصيام
١٠. الاحتياطات المتخذة للمريض المعرضة للسقوط
- الالتزام ب اسورة F
 - ابلاغ الاهل والمرافقين
 - السؤال المتكرر عن الحاجة لدخول الحمام
 - الالتزام بمعايير الأمان البيئي
 - منع الزحام بالغرفة
 - تنقيف المريض والاهل حول الجرس والإنذارات
 - ترك باب الحجرة مفتوح
 - توفير اضاءة ليلا بالغرفة

○ رفع جوانب السرير

- التأكد من عدم انسكاب أي سوائل على أرضية الغرفة
- تفعيل قفل العجل للسرير
- التأكد من خلو طريق سير المريض من أي سلوك أو وصلات
- وضع الأطفال في سرير مناسب الحجم وضبط الارتفاع بما يناسب سنه
- ١١. يتخذ العاملون احتياطاتهم مع المرضى داخل قسم الأشعة حيث يتم تحريك المريض بين أسطح مختلفة (من الكرسي / ترولي الى جهاز الأشعة او سرير الفحص) وفي مناطق الانتظار حيث يجب تجنب الزحام والاصطدام الناس المتواجدين
- ١٢. لا تترك باب الحضانة مفتوحا، ويجب غلق فرامل الحضانات
- ١٣. تثقيف المرضى المعرضين للسقوط وذويهم عن طريق الأطباء المعالجين والتمريض:
- التنبيه على المريض بضرورة إخطار الممرضة في حالة الشعور بدوار أو هبوط أو عدم اتزان.
- التنبيه على المريض بعدم اللجوء إلى حركات فجائية عند تغيير الوضع من النوم إلى الوقوف أو الجلوس.
- التنبيه على المريض بعدم الانحناء لالتقاط أي شيء من الأرض.
- مراعاة استخدام أحذية مريحة بدون كعب ولا تساعد على الانزلاق.
- مراعاة الاحتفاظ بالجرس قرب سرير المريض.
- ضرورة الالتزام بعدم ترك أشياء غير مرغوب بتواجدها على الكومودينو بجوار السرير
- التنبيه على المريض بطلب المساعدة أثناء المشي والتنقل.
- عدم وضع أي آلات حادة بقرب المريض.
- سهولة حركة الفريق الطبي والمرضى وذويهم في طرقات وغرف المستشفى وذلك عن طريق عدم شغلها بأي أدوات أو معدات.
- تشجيع المريض على استخدام سنادات الحائط أثناء السير لمنع السقوط.
- يتم توثيق تقديم هذا التثقيف للمريض وذويه في النموذج المخصص لذلك

١٤. عند تعرض المريض للسقوط يجب إتباع الآتي:

- تقوم الممرضة بتقييم المريض لتحديد أي إصابة أو ضرر.
- في احتمال تعرض المريض للإصابة أو الكسر لا يتم تحريك المريض نهائياً.
- تقوم الممرضة بإخطار الطبيب فحص المريض وتحديد طريقة رفعه
- تقوم الممرضة بمساعدة المريض ورفع طبعاً لتعليمات الطبيب
- تقوم الممرضة بتسجيل حادثة الوقوع في نموذج الأحداث غير المتوقعة
- تقوم الممرضة بتسجيل الواقعة في ملاحظات الممرضة والطبيب في نموذج ملاحظات التقدم الاكلينيكي

المسؤول عن التنفيذ

- أفراد هيئة التمريض.
- الأطباء.
- الصيانة.
- أفراد الأمن
- العمال
- مسؤول الصحة والسلامة المهنية
- فريق الجودة: التدريب على السياسة ومتابعة التنفيذ و التحسين

المراقبة والتقييم

- KPI : يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- تقوم المستشفى بتتبع وجمع وتحليل والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بعملية سقوط المرضى.
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية سقوط المرضى.

النماذج / المرفقات

- نموذج التقييم التمريضي عند الدخول.

- نموذج التقييم التمريضي اليومي.
- نموذج أحداث غير متوقعة.

معايير ذات صلة

ICD.07 Nursing patient assessments; ICD.15 Plan of Care; PCC.07 Patient and family education process

المراجع

دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، إصدار ٢٠٢٥ . معيار ICD.10



اسم المريض :
 رقم الملف الطبي للمريض:
 القسم المعالج :

الهيئة العامة للتأمين الصحي
 فرع:
 المستشفى:

نموذج التقييم التمريضي اليومي للمرضى البالغين

التاريخ الدخول: / / القسم:
 التشخيص:

التاريخ		ص		م		ص		م		ص		م		ص		م	
الحركة																	
- يتحرك بدون مساعدة (٤)																	
- يتحرك بمساعدة جهاز أو شخص (٣)																	
- ملازم المقعد (٢)																	
- ملازم الفراش (١)																	
الادراك																	
(مذكر / غير مذكر)																	
الوعي																	
درجة التقييم (.....)																	
(واعى (١٥-١٣) / شبه واعى (٩-١٢)																	
غيوبية (٨-٣) /																	
غير مستجيب (٣)																	
التغذية																	
(٤-٠)																	
المسقوط																	
أقل من ٣: احتمالية سقوط منخفض																	
أكثر من ٤: احتمالية سقوط عالية																	
درجة تقييم مخاطر فرج الفراش																	
أكثر من ١٨																	
احتمالية منخفضة																	
١٨ - ١٤																	
احتمالية متوسطة																	
١٣ - ١٠																	
احتمالية عالية																	
أقل من ١٠																	
جدا																	
تقييم حالة الجلد																	
اسورة التعريف																	
(موجودة/ غير موجودة)																	
العناية بالوصلات																	
(تم التغيير والحفاظ عليها من الانفصال)																	
التوقيع																	

ملحوظة: يتم الرجوع للتقييم التمريضي عند الدخول في حالة الاحتياج الى معرفة طريقة التقييم

MR.NR.1-2



الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع:
المستشفى:
اسم المريض:
رقم الملف الطبي للمريض:
القسم المعالج:

التقييم التمريضي عند دخول المريض (للبالغين)

القسم: التاريخ: / / الوقت: المسن:
التشخيص الطبي عند الدخول:

تعليمات للمريض

- هل أنت مدخن؟؟ ☐ لا ☐ في السابق ☐ نعم عدد السنوات: عدد السجائر اليومية:
هل تعرف المريض على حقوق المريض ومسئولياته؟ ☐ نعم ☐ لا

التقييم التغذوي

- فحص الفم: ☐ رطب (٠) ☐ جاف (١) ☐ مصاب (١)
 - التاريخ المرضي: ☐ قن وغثيان (١) ☐ صعوبة في البلع (٢) ☐ انخفاض الوزن بدون رجيم (٣)
 - الشهية: ☐ عادية (٠) ☐ أقل من المعتاد (١) ☐ مفقودة (٢)
 - الأسنان: ☐ طقم أسنان (٠) ☐ لا يوجد أسنان مفقودة (٠) ☐ أسنان مفقودة (١)
- مريض الشيخوخة أكثر من ٧٠ سنة دخول عمليات (١)
- سيدة (حامل - رضاعة) (١)
- وصف الغذاء: ☐ عادي (٠) ☐ لين (١) ☐ سائل (٢) / درجة تقييم التغذية: (لو التقييم أكثر من ٤ يتم إبلاغ الطبيب)
وجود ألم: ☐ نعم ☐ لا ☐ مكان الألم: الوقت:

تقييم حالة الجلد

تماسك الجلد: ☐ صحي ☐ مجعد ☐ بقع حمراء ☐ قرح سكر / قرح فراش ☐ جرح غير ملتئم ☐	المكان	الحجم/ الدرجة	اللون	الإفرازات

تقييم مخاطر التعرض لقرح الفراش Norton Scale

درجة التقييم	٤	٣	٢	١
الحالة الصحية	جيدة	متوسطة	ضعيفة	سيئة جدا
الحالة العقلية	واعي ومتنبه	لامبالي	مشتت	غير واع/ غير مدرك
النشاط	يتحرك بدون مساعدة	يتحرك بمساعدة	يتحرك بمساعدة أجهزة (كرسي متحرك)	غير قادر على الحركة
امتكانية الحركة	كاملة	ضعيفة	محدودة جدا	لا يتحرك
السلس البولي	لا يوجد	أحيانا	بولي عادة	التبول والتبرز
الاجمالي				
	☐ أكثر من ١٨ احتمالية منخفضة ☐ من ١٤-١٨ احتمالية متوسطة ☐ من ١٠-١٣ احتمالية عالية ☐ أقل من ١٠ احتمالية عالية جدا			

إجراءات وقاية المريض من قرح الفراش

م	الإجراءات الوقائية
١	وضع المريض على مرتبة هوائية
٢	قم بتقليب المريض كل ساعتين
٣	ذلك جلد المريض وضع مرطبات وفقا لتعليمات الطبيب
٤	اعد تقييم جلد المريض كل ساعتين في نموذج تقييم المريض

MR.NR.1-2

نموذج الأحداث غير المتوقعة

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع :
مستشفى :

OCCURRENCE VARIANCE REPORT (OVR)
(.....) OVR Code No.

THIS FORM SHOULD BE FORWARDED TO THE QUALITY DEPARTMENT WITHIN 72 HOURS
يجب أن يسلم النموذج لقسم الجودة في خلال 72 ساعة

Reported by Name (OPTIONAL): اسم المبلغ (اختياري)	Department: القسم
Reported by Signature: توقيع المبلغ	Date of Reporting: تاريخ التبليغ

INDIVIDUAL OR MEMBER OF STAFF INVOLVED (Tick One or More)

☐ Nurse ممرضة	☐ Physician طبيب	☐ Administrative إداري	☐ Patient مريض
☐ Nursing Aid مساعد ممرضة	☐ Technician فني	☐ Security فرد أمن	☐ Other أخرى

OCCURRENCE INFORMATION

Date of Incident تاريخ الحادث	Time of Incident وقت وقوع الحادث	Location/Unit الوحدة/المكان
Name of Person Involved اسم الشخص المعني	Patient I.D: رقم الملف الطبي	☐ Female أنثى ☐ Male ذكر

Briefly describe the incident/ occurrence and attach the supporting data when applicable
وصف ملخص للحدث مع الدعم بمستند إذا أمكن

Immediate Corrective Action taken: To be completed by involved/concerned department
الإجراء التصحيحي المتخذ: يتم كتابته من قبل الشخص المسئول

Suggested Preventive Action: To be completed by the concerned Head of Department for follow up
الإجراء التصحيحي المقترح: يتم كتابته من قبل رئيس القسم المختص

Name: الاسم: Date: التاريخ: Time: الوقت: Signature: التوقيع:

O.V.R. 1-2